Abacavir

116084008

CÓDIGO	116084008
CATEGORÍA	Farmacología clínica

EXPLICADO SIMPLE

compuesto químico

DEFINICIÓN CLÍNICA

Abacavir Tarbis está indicado en el tratamiento antirretroviral combinado para el tratamiento de la infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) en adultos, adolescentes y niños (ver secciones 4.4 y 5.1).

La demostración del beneficio del tratamiento con Abacavir Tarbis se basa principalmente en los resultados de los estudios realizados con un régimen de dos veces al día en pacientes adultos que no habían recibido previamente un tratamiento combinado (ver sección 5.1)

Antes de iniciar el tratamiento con abacavir, se debe llevar a cabo una prueba de detección del alelo HLA-B*5701 en los pacientes infectados por el VIH, independientemente del origen racial (ver sección 4.4). Abacavir no se debe emplear en pacientes portadores del alelo HLA-B*5701.

Fuente de la definición: AEMPS. CIMA. Ficha técnica de ABACAVIR TARBIS 300 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG (nº reg. 84740), sección 4.1 «Indicaciones terapéuticas», versión del 2024-01-22. · https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/84740/FT_84740.html

Fuente del término: CIMA — Centro de Información online de Medicamentos de la AEMPS · https://cima.aemps.es/cima/rest/medicamentos

PARA QUÉ SE INDICA

En la fuente: 4.1 Indicaciones terapéuticas

Abacavir Tarbis está indicado en el tratamiento antirretroviral combinado para el tratamiento de la infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) en adultos, adolescentes y niños (ver secciones 4.4 y 5.1). Antes de iniciar el tratamiento con abacavir, se debe llevar a cabo una prueba de detección del alelo HLA-B*5701 en los pacientes infectados por el VIH, independientemente del origen racial (ver sección 4.4). Abacavir no se debe emplear en pacientes portadores del alelo HLA-B*5701.

Fuente: aemps-cima · https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/84740/4.1/FichaTecnica.html · AEMPS — reproducción autorizada citando el origen y la fecha de la última actualización del documento (https://www.aemps.gob.es/aviso-legal/) · versión 2024-01-23 · ficha técnica del producto con registro 84740 · consultado el 30/09/2026 · 4.1 Indicaciones terapéuticas

CONTRAINDICACIONES

En la fuente: 4.3 Contraindicaciones

Hipersensibilidad a abacavir o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Ver secciones 4.4 y 4.8.

Fuente: aemps-cima · https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/84740/4.3/FichaTecnica.html · AEMPS — reproducción autorizada citando el origen y la fecha de la última actualización del documento (https://www.aemps.gob.es/aviso-legal/) · versión 2024-01-23 · ficha técnica del producto con registro 84740 · consultado el 30/09/2026 · 4.3 Contraindicaciones

POBLACIONES ESPECIALES

En la fuente: 4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo

Reacciones de hipersensibilidad (ver también sección 4.8) Abacavir está asociado a un riesgo de reacciones de hipersensibilidad (RHS) (ver sección 4.8) caracterizadas por fiebre y/o erupción con otros síntomas que indican implicación multiorgánica. Se han observado RHS con abacavir, algunas de las cuales han sido potencialmente mortales, y en algunos casos han sido mortales, cuando no se han tratado adecuadamente. El riesgo de que ocurran RHS con abacavir es alto para pacientes portadores del alelo HLA-B*5701. Sin embargo, las RHS con abacavir se notificaron con menor frecuencia en pacientes que no eran portadores de este alelo. Por tanto, se debe seguir lo siguiente: Se debe documentar el estatus del HLA-B*5701 antes de iniciar el tratamiento. Abacavir Tarbis nunca se debe iniciar en pacientes con HLA-B*5701 positivo, ni en pacientes con HLA-B*5701 negativo que hayan tenido sospecha de RHS a abacavir en tratamientos previos con medicamentos que contenían abacavir (ej: Kivexa, Trizivir, Triumeq). Abacavir Tarbis se debe interrumpir inmediatamente, incluso en ausencia del alelo HLA-B*5701 si se sospecha de RHS. El retraso en la interrupción del tratamiento con Abacavir Tarbis tras el comienzo de la hipersensibilidad puede ocasionar una reacción que pueda ser potencialmente mortal. Tras la interrupción del tratamiento con Abacavir Tarbis por razones de sospecha de RHS, no se debe reiniciar el tratamiento ni con Abacavir Tarbis ni con ningún otro medicamento que contenga abacavir (ej: Kivexa, Trizivir, Triumeq). Si se reinicia el tratamiento con medicamentos que contengan abacavir tras una sospecha de RHS a abacavir puede ocasionar una reaparición de los síntomas en horas. Esta recurrencia es normalmente más grave que la inicial y puede incluir una hipotensión que puede ser potencialmente mortal y ocasionar la muerte. Con el fin de evitar un reinicio del tratamiento con abacavir, a los pacientes que hayan sufrido una sospecha de RHS a abacavir se les debe indicar que se deshagan de los comprimidos de Abacavir Tarbis que les queden. Descripción clínica de la RHS a abacavir Las RHS han sido bien caracterizadas durante los ensayos clínicos y la experiencia pos-comercialización. Los síntomas normalmente aparecen en las primeras seis semanas (la mediana de tiempo de aparición es de 11 días) desde el inicio del tratamiento con abacavir, aunque estas reacciones pueden aparecer en cualquier momento durante el tratamiento. En casi todas las RHS aparecerán fiebre y/o erupción. Otros signos y síntomas que han sido observados como parte de las RHS se describen en detalle en la sección 4.8 (Descripción de Reacciones Adversas Seleccionadas) incluyendo síntomas respiratorios y gastrointestinales. De forma importante, estos síntomas pueden dar lugar a que se diagnostique equivocadamente una RHS como una enfermedad respiratoria (neumonía, bronquitis, faringitis) o gastroenteritis. Los síntomas relacionados con RHS empeoran al continuar el tratamiento y pueden poner en peligro la vida del paciente. Generalmente, estos síntomas se resuelven tras suspender la administración de abacavir. Raramente, pacientes que han interrumpido el

tratamiento con abacavir por otras razones que no eran síntomas de RHS también han sufrido reacciones potencialmente mortales al cabo de unas horas tras reiniciar el tratamiento con abacavir (ver sección 4.8 Descripción de Reacciones Adversas Seleccionadas). El reinicio del tratamiento en estos pacientes se debe hacer en un lugar donde haya disponibilidad de asistencia médica. Disfunción mitocondrial tras la exposición en el útero Los análogos de nucleós(t)idos pueden afectar a la función mitocondrial en un grado variable, siendo más marcado con la estavudina, la didanosina y la zidovudina. Ha habido informes de disfunción mitocondrial en bebés VIH negativo expuestos en el útero y/o post-parto a análogos de nucleósidos; estos concernieron predominantemente al tratamiento con regímenes que contenían zidovudina. Las principales reacciones adversas notificadas fueron trastornos hematológicos (anemia, neutropenia) y trastornos metabólicos (hiperlactatemia, hiperlipasemia). Estas reacciones fueron a menudo transitorias. Se han notificado raramente trastornos neurológicos de aparición tardía (hipertonía, convulsión, comportamiento anormal). Actualmente no se sabe si estos trastornos neurológicos son transitorios o permanentes. Estos hallazgos se deben considerar en cualquier niño expuesto en el útero a análogos de nucleós(t)idos que presenten hallazgos clínicos graves de etiología desconocida, especialmente hallazgos neurológicos. Estos hallazgos no afectan a las recomendaciones nacionales actuales para utilizar tratamiento antirretroviral en mujeres embarazadas para prevenir la transmisión vertical del VIH. Peso y parámetros metabólicos Durante el tratamiento antirretroviral se puede producir un aumento en el peso y en los niveles de glucosa y lípidos en la sangre. Tales cambios podrían estar relacionados en parte con el control de la enfermedad y en parte con el estilo de vida. Para los lípidos, hay en algunos casos evidencia de un efecto del tratamiento, mientras que para la ganancia de peso no hay una evidencia sólida que relacione esto con un tratamiento en particular. Para monitorizar los niveles de lípidos y de glucosa en la sangre, se hace referencia a pautas establecidas en las guías de tratamiento del VIH. Los trastornos lipídicos se deben tratar como se considere clínicamente apropiado. Pancreatitis Se ha comunicado la aparición de pancreatitis, pero la relación causal con el tratamiento con abacavir es incierta. Terapia triple con nucleósidos En pacientes con elevada carga viral (>100.000 copias/ml) la elección de una combinación triple con abacavir, lamivudina y zidovudina necesita una consideración especial (ver sección 5.1). Enfermedad hepática No se ha establecido la seguridad y eficacia de Abacavir Tarbis en pacientes con trastornos hepáticos subyacentes significativos. En pacientes con disfunción hepática preexistente, incluyendo hepatitis crónica activa, la frecuencia de anormalidades de la función hepática durante el tratamiento antirretroviral combinado es mayor y los pacientes deben ser controlados de acuerdo a la práctica estándar. Si existe evidencia de empeoramiento de la enfermedad hepática en estos pacientes, debe considerarse la interrupción o suspensión del tratamiento. Pacientes co-infectados con el virus hepatitis B o C crónica Los pacientes con hepatitis B o C crónica tratados con un tratamiento antirretroviral combinado tienen un mayor riesgo de tener reacciones adversas hepáticas graves y potencialmente mortales. En caso de tratamiento antiviral concomitante para hepatitis B o C, por favor consúltese también la información relevante del producto de estos medicamentos. Enfermedad renal No se debe administrar Abacavir Tarbis a pacientes con enfermedad renal en fase terminal (ver sección 5.2). Síndrome de Reconstitución Inmune Cuando se instaura un tratamiento antirretroviral combinado (TARC), en pacientes infectados por el VIH con deficiencia inmunitaria grave, puede aparecer una respuesta inflamatoria frente a patógenos oportunistas latentes o asintomáticos y provocar situaciones clínicas graves, o un empeoramiento de los síntomas. Normalmente, estas reacciones se han observado en las primeras semanas o meses después del inicio del TARC. Algunos ejemplos relevantes de estas reacciones son, retinitis por citomegalovirus, infecciones micobacterianas generalizadas y/o localizadas, y neumonía por Pneumocystis carinii. Se debe evaluar cualquier síntoma inflamatorio y establecer un tratamiento cuando sea necesario. También se ha notificado la aparición de trastornos autoinmunitarios (como por ejemplo la enfermedad de Graves y la hepatitis autoinmune) durante la reconstitución inmune; sin embargo, el tiempo notificado hasta su aparición es más variable y estos acontecimientos pueden suceder muchos meses

después del inicio del tratamiento. Osteonecrosis Se han notificado casos de osteonecrosis, especialmente en pacientes con infección avanzada por el VIH y/o exposición prolongada al TARC, aunque se considera que la etiología es multifactorial (incluyendo uso de corticoesteroides, consumo de alcohol, inmunosupresión grave, índice de masa corporal elevado). Se debe aconsejar a los pacientes que consulten al médico si experimentan molestias o dolor articular, rigidez articular o dificultad para moverse. Infecciones oportunistas Los pacientes que estén recibiendo Abacavir Tarbis o cualquier otro tratamiento antirretroviral aún pueden desarrollar infecciones oportunistas y otras complicaciones de la infección por el VIH. En consecuencia, los pacientes deben permanecer bajo estrecha observación clínica por médicos con experiencia en el tratamiento de estas enfermedades asociadas al VIH. Transmisión A pesar de que se ha probado que la supresión viral con tratamiento antirretroviral eficaz reduce sustancialmente el riesgo de transmisión sexual, no se puede excluir un riesgo residual. Se deben tomar precauciones, conforme a las directrices nacionales, para prevenir la transmisión. Eventos cardiovasculares Aunque los datos disponibles de estudios clínicos y observacionales con abacavir muestran resultados inconsistentes, varios estudios sugieren un mayor riesgo de eventos cardiovasculares (especialmente infarto de miocardio) en pacientes tratados con abacavir. Por lo tanto, al prescribira Abacavir Tarbis, se deben tomar medidas para tratar de minimizar todos los factores de riesgo modificables (por ejemplo fumar, la hipertensión y la hiperlipidemia). Además, cuando se trata a pacientes con un alto riesgo cardiovascular se deben considerar opciones de tratamiento alternativas al régimen que contiene abacavir. Abacavir Tarbis contiene sodio

Fuente: aemps-cima · https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/84740/4.4/FichaTecnica.html · AEMPS — reproducción autorizada citando el origen y la fecha de la última actualización del documento (https://www.aemps.gob.es/aviso-legal/) · versión 2024-01-23 · ficha técnica del producto con registro 84740 · consultado el 30/09/2026 · 4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo

INTERACCIONES

En la fuente: 4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción

En función de los resultados de las pruebas in vitro y de las principales vías metabólicas conocidas de abacavir, la posibilidad de que tengan lugar interacciones con otros medicamentos en las que esté implicado abacavir, mediadas por el citocromo P450, es baja. El P450 no desempeña una función principal en el metabolismo de abacavir y abacavir no inhibe el metabolismo mediado por la CYP 3A4. También se ha demostrado in vitro que abacavir no inhibe las enzimas CYP 3A4, CYP2C9 o CY2D6 a concentraciones clínicamente relevantes. En los estudios clínicos no se ha observado inducción del metabolismo hepático. Por lo tanto, la posibilidad de que existan interacciones con IPs antirretrovirales y otros medicamentos metabolizados por las principales enzimas P450, es escasa. Los estudios clínicos han demostrado que no se dan interacciones clínicamente significativas entre abacavir, zidovudina y lamivudina. Potentes inductores enzimáticos como rifampicina, fenobarbital y fenitoína pueden disminuir ligeramente las concentraciones plasmáticas de abacavir por su acción sobre las UDP-glucuroniltransferasas. Estos hallazgos no se consideran clínicamente significativos. Abacavir carece de efecto sobre el metabolismo de etanol. Los cambios en la farmacocinética de abacavir no se consideran clínicamente relevantes. Por tanto, no puede excluirse la inducción de las enzimas metabolizadoras del fármaco. Retinoides: los compuestos retinoides se eliminan mediante la alcohol deshidrogenasa. Es posible la interacción con abacavir pero no ha sido estudiada.

Fuente: aemps-cima · https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/84740/4.5/FichaTecnica.html · AEMPS — reproducción autorizada citando el origen y la fecha de la última actualización del documento (https://www.aemps.gob.es/aviso-legal/) · versión 2024-01-23 · ficha técnica del producto con registro

84740 · consultado el 08/10/2026 · 4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción

EMBARAZO Y LACTANCIA

En la fuente: 4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia

Embarazo Como norma general, cuando se tome la decisión de utilizar agentes antirretrovirales para el tratamiento de la infección por el VIH en mujeres embarazadas, y por consiguiente reducir el riesgo de transmisión vertical al recién nacido, se deben tener en cuenta los datos obtenidos tanto en animales como en la práctica clínica en mujeres embarazadas. Los estudios en animales han mostrado toxicidad para el embrión y el feto en desarrollo en ratas, pero no así en conejos (ver sección 5.3.). Abacavir ha demostrado ser carcinogénico en modelos animales (ver sección 5.3). Se desconoce la relevancia clínica de estos datos en humanos. Se ha demostrado que en humanos se produce transferencia placentaria de abacavir y/o sus metabolitos relacionados. En mujeres embarazadas, después del primer trimestre de exposición, los resultados en más de 800 casos y en más de 1.000 casos después del segundo y tercer trimestre de exposición al medicamento, no indican ninguna malformación o efecto fetal/neonatal de abacavir. En base a esos datos, el riesgo de malformación es poco probable en los seres humanos. Disfunción mitocondrial Los análogos de nucleósidos y nucleótidos han demostrado in vitro e in vivo causar un grado variable de daño mitocondrial. Ha habido notificaciones de disfunción mitocondrial en lactantes VIH-negativos expuestos a análogos de nucleósido en el útero y/o después del nacimiento (ver sección 4.4). Lactancia Abacavir y sus metabolitos se excretan en la leche de ratas en periodo de lactancia. Abacavir también se excreta en la leche materna. No se dispone de datos sobre la seguridad de abacavir cuando se administra a niños menores de tres meses. Se recomienda que las mujeres infectadas por el VIH no den el pecho a sus hijos bajo ninguna circunstancia, con el fin de evitar la transmisión del VIH. Fertilidad Estudios en animales han mostrado que abacavir no tuvo efecto sobre la fertilidad (ver sección 5.3).

Fuente: aemps-cima · https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/84740/4.6/FichaTecnica.html · AEMPS — reproducción autorizada citando el origen y la fecha de la última actualización del documento (https://www.aemps.gob.es/aviso-legal/) · versión 2024-01-23 · ficha técnica del producto con registro 84740 · consultado el 08/10/2026 · 4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia

REACCIONES ADVERSAS

En la fuente: 4.8 Reacciones adversas

En el caso de muchas reacciones adversas comunicadas, no está claro si están relacionadas con Abacavir Tarbis, con el amplio número de medicamentos utilizados en el tratamiento de la infección por el VIH o si son consecuencia del proceso de la enfermedad. Muchas de las reacciones incluidas a continuación se producen frecuentemente (náuseas, vómitos, diarrea, fiebre, letargo, erupción) en pacientes con hipersensibilidad a abacavir. Por lo tanto, en los pacientes con cualquiera de estos síntomas se debe evaluar cuidadosamente la aparición de esta reacción de hipersensibilidad. Si se ha interrumpido el tratamiento con Abacavir Tarbis en los pacientes por haber experimentado cualquiera de estos síntomas y se decide reiniciar el tratamiento con un medicamento que contenga abacavir, esto debe realizarse teniendo en cuenta que la asistencia médica esté fácilmente disponible (ver sección 4.4.). Muy raramente se han notificado casos de eritema multiforme, Síndrome de Stevens-Johnson y necrolisis epidérmica tóxica en los que no se puede descartar hipersensibilidad a abacavir. En estos casos debe interrumpirse permanentemente el tratamiento con medicamentos que contengan abacavir. Muchas de las reacciones

adversas no han sido limitantes del tratamiento. Se ha empleado el siguiente criterio para su clasificación: muy frecuentes (≥1/10), frecuentes (≥1/100 a <1/10), poco frecuentes (≥1/1.000 a <1/100), raras (≥1/10.000 a <1/1.000), muy raras (<1/10.000). Trastornos del metabolismo y de la nutrición Frecuentes: anorexia Trastornos del sistema nervioso Frecuentes: dolor de cabeza Trastornos gastrointestinales Frecuentes: náuseas, vómitos, diarrea Raras: pancreatitis. Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo Frecuentes: erupción (sin síntomas sistémicos) Muy raras: eritema multiforme, síndrome de Stevens-Johnson y necrolisis epidérmica tóxica. Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración Frecuentes: fiebre, letargo, fatiga Descripción de Reacciones Adversas Seleccionadas Reacciones de hipersensibilidad a abacavir Los signos y síntomas de las RHS se describen a continuación. Estos se han identificado o bien en los ensayos clínicos o en vigilancia pos comercialización. Casi todos los pacientes que desarrollan reacciones de hipersensibilidad tienen fiebre y/o erupción (normalmente maculopapular o urticariforme) como parte del síndrome, sin embargo, algunas reacciones han tenido lugar sin erupción ni fiebre. Otros síntomas clave incluyen síntomas gastrointestinales, respiratorios o constitucionales como letargo y malestar. Cutáneos Erupción (generalmente maculopapular o urticariforme) Tracto gastrointestinal Náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, úlceras bucales Tracto respiratorio Disnea, tos, dolor de garganta, síndrome de distress respiratorio en el adulto, fallo respiratorio Otros Fiebre, letargo, malestar, edema, linfadenopatía, hipotensión, conjuntivitis, anafilaxia Neurológicos/Psiquiátricos Cefalea, parestesias Hematológicos Linfopenia Hepáticos/Pancreáticos Pruebas de función hepática elevadas, hepatitis, fallo hepático Musculoesqueléticos Mialgia, raramente miolisis, artralgia, creatina fosfoquinasa elevada Urológicos Creatinina elevada, fallo renal Los síntomas relacionados con esta RHS empeoran con el tratamiento prolongado y puede suponer una amenaza para la vida y en casos raros, han sido fatales. Reiniciar abacavir tras una RHS con abacavir puede resultar en una rápida reaparición de los síntomas en cuestión de horas. La recurrencia de las RHS es normalmente más grave que en la aparición inicial y puede incluir una hipotensión que pueda ser potencialmente mortal, e incluso mortal. Han tenido lugar reacciones similares de forma no frecuente tras reiniciar el tratamiento con abacavir en pacientes que tuvieron solamente uno de los síntomas clave de hipersensibilidad (ver arriba) antes de interrumpir abacavir y en muy raras ocasiones también se ha observado en pacientes que han reiniciado el tratamiento sin síntomas precedentes de RHS (ej. pacientes que anteriormente se habían considerado tolerantes a abacavir). Peso y parámetros metabólicos El peso y los niveles de glucosa y lípidos en la sangre pueden aumentar durante el tratamiento antirretroviral (ver sección 4.4) Síndrome de Reconstitución Inmune Al inicio del tratamiento antirretroviral combinado (TARC), en los pacientes infectados por el VIH con deficiencia inmunitaria grave, puede aparecer una respuesta inflamatoria frente a infecciones oportunistas latentes o asintomáticas. También se han notificado trastornos autoinmunitarios (como por ejemplo la enfermedad de Graves y la hepatitis autoinmune); sin embargo, el tiempo notificado hasta su aparición es más variable y estos acontecimientos pueden suceder muchos meses después del inicio del tratamiento (ver sección 4.4). Osteonecrosis Se han notificado casos de osteonecrosis, especialmente en pacientes con factores de riesgo generalmente reconocidos, enfermedad avanzada por el VIH o exposición prolongada al TARC. Se desconoce la frecuencia de esta reacción adversa (ver sección 4.4). Cambios en pruebas de laboratorio En estudios clínicos controlados, las alteraciones de laboratorio relacionadas con el tratamiento con Abacavir Tarbis fueron poco frecuentes, no observándose diferencias en cuanto a la incidencia entre pacientes tratados con Abacavir Tarbis y los brazos control. Población pediátrica Notificación de sospechas de reacciones adversas Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: https://www.notificaram.es.

Fuente: aemps-cima · https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/84740/4.8/FichaTecnica.html · AEMPS — reproducción autorizada citando el origen y la fecha de la última actualización del documento

(https://www.aemps.gob.es/aviso-legal/) · versión 2024-01-23 · ficha técnica del producto con registro 84740 · consultado el 30/09/2026 · 4.8 Reacciones adversas

CLASE FARMACOLÓGICA

En la fuente: 5.1 Propiedades farmacodinámicas (grupo farmacoterapéutico)

Grupo farmacoterapéutico: inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de nucleósidos, Código ATC: J05AF06

Fuente: aemps-cima · https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/84740/5.1/FichaTecnica.html · AEMPS — reproducción autorizada citando el origen y la fecha de la última actualización del documento (https://www.aemps.gob.es/aviso-legal/) · versión 2024-01-23 · ficha técnica del producto con registro 84740 · consultado el 30/09/2026 · 5.1 Propiedades farmacodinámicas (grupo farmacoterapéutico)

PRESENTACIONES

En la fuente: Forma farmacéutica y vía de administración (listado de medicamentos de CIMA)

COMPRIMIDO RECUBIERTO — VÍA ORAL COMPRIMIDO RECUBIERTO CON PELÍCULA — VÍA ORAL SOLUCIÓN ORAL — VÍA ORAL

Fuente: aemps-cima · https://cima.aemps.es/cima/publico/detalle.html?nregistro=84740 · AEMPS — reproducción autorizada citando el origen y la fecha de la última actualización del documento (https://www.aemps.gob.es/aviso-legal/) · versión 2026-09-30 · consultado el 30/09/2026 · Forma farmacéutica y vía de administración (listado de medicamentos de CIMA)

DATOS

CÓDIGO ATC	J05AF06 · Abacavir

Fuente: aemps-cima · https://cima.aemps.es/cima/publico/detalle.html?nregistro=84740

CLASE ATC (NIVEL 3)	J05A · ANTIVIRALES DE ACCION DIRECTA

Fuente: aemps-cima · https://cima.aemps.es/cima/publico/detalle.html?nregistro=84740

CLASE ATC (NIVEL 4)	J05AF · Nucleosidos y nucleotidos inhibidores de la transcriptasa inversa

Fuente: aemps-cima · https://cima.aemps.es/cima/publico/detalle.html?nregistro=84740

VÍAS DE ADMINISTRACIÓN AUTORIZADAS	VÍA ORAL

Fuente: aemps-cima · https://cima.aemps.es/cima/publico/detalle.html?nregistro=84740

MEDICAMENTOS AUTORIZADOS CON ESTE PRINCIPIO ACTIVO (CIMA)	5 (3 comercializados al 2026-09-30)

Fuente: aemps-cima · https://cima.aemps.es/cima/publico/detalle.html?nregistro=84740

Nº DE REGISTRO DEL MEDICAMENTO CUYA FICHA SE CITA	84740

Fuente: aemps-cima · https://cima.aemps.es/cima/publico/detalle.html?nregistro=84740

REFERENCIAS

Ficha técnica oficial (CIMA, AEMPS) · https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/84740/FT_84740.html